

Rastreamento · vs diagnóstico precoce

Rastreamento busca doença em assintomáticos; diagnóstico precoce investiga sintoma. Em prova, cobre critérios de um bom programa e vieses de lead time/length time.

Rastreamento "vs" diagnóstico precoce

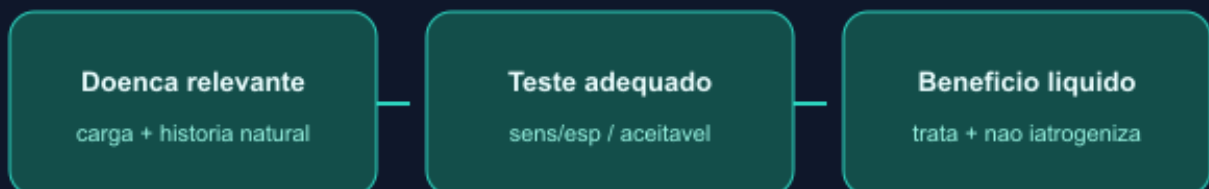
Lembre - Rastreamento "vs" diagnóstico precoce

Rastreamento: população assintomática (ex.: mamografia de rotina). Diagnóstico precoce: paciente com sinal/sintoma (ex.: nódulo palpável !' investigação).

Fluxo conceitual: problema relevante !' teste aceitável !' tratamento que muda desfecho sem dano excessivo.

Rastreamento em 3 ideias

Doença importante -> teste útil -> benefício líquido



CrITÉRIOS clássicos (Wilson-Jungner — ideia)

- Doença importante e com fase latente detectável
- Teste sensível, específico, aceitável e seguro
- Tratamento eficaz disponível e custo aceitável
- Processo contínuo, não 'mutirão sem seguimento'

Vieses que caem em prova

Viés | Ideia

Lead time | Diagnóstico mais cedo sem alongar sobrevida real

Length time | Rastreio pega tumores lentos (melhor prognóstico aparente)

Seleção | Quem adere ao rastreio já é diferente

Sobrediagnóstico | Detecta o que não ia adoecer clinicamente

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Teste com alta sensibilidade não justifica rastreamento sozinho. Sem tratamento que melhore desfecho (ou com muitos falsos positivos), o programa pode só gerar dano e custo.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Rastreamento bom obedece princípios tipo Wilson-Jungner: doença importante, história natural conhecida, teste aceitável e tratamento que muda desfecho.

Checklist mental: só rastreie se doença, teste e tratamento fizerem sentido populacional.

Wilson-Jungner (ideia)

Critérios clássicos de rastreio

- 1 Doença importante (carga / gravidade)
- 2 História natural conhecida; fase latente detectável
- 3 Teste sensível, específico, aceitável e acessível
- 4 Tratamento eficaz que muda prognóstico
- 5 Política clara de quem tratar; custo aceitável
- 6 Rastreio contínuo, não episódio único

Mesmo com boa especificidade, VPP cai se a prevalência for baixa.

Valor preditivo

Prevalência manda no VPP

VPP sobe com prevalência

Rastreio em baixo risco → muitos falso-positivos

Wilson-Jungner — versão de prova

Critério | Pergunta-chave

Importância da doença | Há carga relevante de morbimortalidade?

História natural | Existe fase pré-clínica detectável?

Teste | É aceitável, confiável e disponível?

Tratamento | Intervir cedo melhora desfecho?

Programa | Há consenso, recursos e seguimento?

Equilíbrio | Benefício supera danos e custos?

Danos do rastreamento

- Falso-positivo !' ansiedade, exames invasivos
- Overdiagnosis !' tratar o que não iria prejudicar
- Falso-negativo !' falsa segurança
- Lead time / length bias — parecer que 'vive mais' sem ganho real

Armadilha

Atencao - Armadilha

Ter teste disponível não basta. Sem tratamento eficaz ou sem população-alvo definida, rastrear pode só gerar dano.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1